病理検査室における録画システムによる医療安全の取り組み

病理検査室における録画システムによる医療安全の取り組み

◎髙橋 羽菜[1)]、小泉 崚[1)]、福田 淳[1)]
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院[1)]

【はじめに】

病理組織検査は、患者より採取した組織を標本化し確定診断を行う重要な検査である。しかし、標本作製工程には手作業が多く含まれており、ヒューマンエラーによる検体取り違えや処理過程での確認不足が診断精度に影響を及ぼす危険性がある。当院では2021年より、切出し作業時にデジタルカメラを用いてカセット投入前の検体状態を静止画として記録していたが、さらなる医療安全およびトレーサビリティ向上を目的として、2023年に動画記録カメラシステムを導入した。今回、録画システム導入後の運用面および医療安全面での有用性について報告する。

【導入機器】

㈱常光製動画記録カメラシステムを導入した。本システムは撮影用カメラ、記録用ハードディスクおよびモニターで構成される。

【方法】

撮影用カメラを病理医による切出しエリア、技師による切出し介助エリア、細胞診検体処理エリアに各1台設置し、作業全体が確認可能となるよう配置した。また、切出し介助エリアには依頼箋内容を確認可能とするため追加で1台設置した。映像はモニター上でリアルタイムおよび過去記録の確認が可能であり、録画データは約3か月間保存される設定とした。録画時間は、病理医切出しエリアおよび細胞診検体処理エリアを8時30分から19時まで、切出し介助エリアを8時30分から23時までとした。

【結果・まとめ】

録画システム導入により、検体処理過程における作業状況の即時確認が可能となり、問題発生時の原因検索および状況把握を迅速に行うことができた。また、切出し以降の工程で確認事項が生じた際にも、録画映像を用いることで検体取り扱い状況の追跡が可能となり、トレーサビリティが大幅に向上した。さらに、作業工程の可視化によりスタッフ間での確認意識が向上し、検体取り違え防止に対する安全管理体制の強化につながった。

聖隷三方原病院－053-436-1251（内線3550）